

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	小兒腹膜透析術 Pediatric Peritoneal Dialysis				
編號	A31000-Q05-W-D14	制定者	PI 蔡宜溝	公佈日期	103 年 06 月 04 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 03 月 08 日
版本/總頁數	第 1.4 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 15 日

一、目的

護理人員能正確執行小兒腹膜透析之護理。

二、範圍

兒科各單位。

三、說明

（一）適應症

1. 急性腎衰竭。
2. 急性中毒。
3. 血中電解質異常與尿酸過高症。

（二）技術目的

1. 排除含氮廢物與矯正酸鹼平衡與電解質平衡。
2. 排除外來毒物。
3. 可作為生化學、細胞學及細菌培養。

（三）用物準備

1. 皮膚消毒用物：Tr.Iodine、75% Alcohol、0.9% N/S、B- Iodine 各 1 組。
2. 髮帽、無菌手套、手術衣。
3. 治巾一包及小眼洞巾一條。
4. 刀片。
5. 彎 mosquito 1 支。
6. 持針器。

主題名稱	小兒腹膜透析術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D14	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	2/6

7. 針線(3.0 Dermalon)。
8. 無菌線剪 2 支。
9. Tenchhoff 導管或胸管(8~20Fr.)。
10. 直接管、精密尿量桶、精密 bag。
11. 腹膜透析液（需事先加溫）1.5%、2.5%、4.25%。
12. 輸液加溫器、大量 pump 一台。
13. Heparin 500 u。
14. 4×4 紗布 2 包、3×3 紗布 5 包、Y 紗一包。
15. 止血鉗 1 支。
16. 請醫師以 5 c.c.空針抽局部麻醉劑 2% Xylocaine。
17. Mifex 一捲。
18. 寬布膠一捲。
19. 各類試管。

（四）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 核對醫囑及辨識病人（至少二種以上方法）。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
2. 向病童或家屬解釋小兒腹膜透析技術的目的及填寫同意書。	1.詳細的說明使病童或家屬能了解治療之目的以減輕焦慮。 2.確認同意書是否簽署完整。
3. 排空膀胱，避免膀胱被穿刺。	
4. 洗手。	
5. 予以病童適當擺位並行適宜之約束。	約束時注意末梢血循。
6. 避免病童因疼痛躁動而無法配合，依醫囑適當的給予鎮靜劑。	密切觀察病童生命徵象，尤其呼吸，病童單位備好 Ambu、Mask、one way、O2。
7. 露出穿刺部位。	
8. 協助醫師以 2 %Tr. Idoine 及 75 %Alcohol 三次消毒穿刺部位。	

主題名稱	小兒腹膜透析術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D14	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
9.協助醫師穿戴口罩、髮帽、無菌手術衣後再戴無菌手套。	
10.協助醫師鋪上治巾及小眼洞巾。	請醫師先取小眼洞巾。
11.以無菌技術遞刀片給醫師。	
12.以無菌技術遞彎 mosquito 1 支給醫師。	
13.以無菌技術遞 Tenchhoff 導管（矽膠等生物相容性佳的材質，有很多孔，有 2 個 cuff 可固定）或胸管給醫師。	打開 Tenchhoff 導管包裝時注意無菌，Tenchhoff 導管易滑脫出。
14.醫師確認位置無誤，以無菌技術遞針線(3.0 Dermalon)或（縫針及縫線）、持針器給醫師，協助用縫線將胸管固定在皮膚上。	
15.清潔血跡及消毒(0.9% N/S+B-Iodine)後，以 Y 紗固定，再以無菌紗布覆蓋 Mifex 固定之。	
16.追蹤 KUB 確認管路位置，若位置正確予以進行腹膜透析。	
17.將透析液接上精密 bag 及精密尿量筒並加溫（事先加入 Heparin 500u）。	依醫囑給予濃度適當的透析液（加入 Heparin 500u）。
18.以固定夾固定引流管。	
19.每公斤以 10 ml 的透析液，在 10 分鐘內給完，停留在腹腔 20 分鐘，並持續 30 分鐘放液。	
20.記錄腹膜透析紀錄單及護理紀錄。	
21.觀察及記錄引流液之性質、顏色、量、引流速度、腹膜透析管穿刺和放置時間，及病童反應、生命徵象等。	
22.觀察腹膜透析的功能及效果。	若腹膜透析效果不佳，則通知醫師處理。
23.整理病人單位，清洗用物後歸位。	
24.洗手。	
25.觀察及記錄病童有無不良反應。	觀察有無腹膜炎之症狀例如：發燒、嗜中性白血球上升、白血球上升、腹膜透析液混濁等異常情形。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	小兒腹膜透析術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D14	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	4/6

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 陳月枝總校閱(2010)·腎衰竭的技術性處理(p1807-1821頁)·小兒科護理學·台北：華杏。
- (二) 吳碧娟、邱益煌(2010)·腹膜透析兒童營養照護·腎臟與透析，22(3)，188 - 201。
- (三) 陳河卿、洪士元(2014)·連續性可攜帶式腹膜透析與全自動腹膜透析之使用原則·台灣腎臟醫學會季刊，26(2)，79-83。

七、附件

(略)

主題名稱	小兒腹膜透析術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D14	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
103.06.04	1.0	新制定。	103 年 06 月 04 日 護理部技術標準 委員會通過；103 年 06 月 04 日公 布。
103.06.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.12.15	1.1	1. 第三項說明內容用辭修正。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 12 月 15 日 護理部技術標準 委員會通過。
105.12.20	1.2	修正第三項第(四)目之 1 病人辨識說明。	105 年 12 月 20 日 護理部技術標準 委員會通過。
106.12.18	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.12.16	1.3	第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施， 改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布 實施。	108 年 12 月 09 日 護理技術組會議 通過；108 年 12 月 11 日護理長會 議通過；108 年 12 月 16 日督導會 議通過公布。
109.12.14	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.03.08	1.4	1. 修正第三項第三目之用物準備。 2. 修正第三項第四目之 6 步驟說明。 3. 第三項第四目之 2 修正說明。	110 年 12 月 13 日 護理技術組會議 通過；111 年 01 月 12 日護理長會 議通過；111 年 03 月 08 日督導會 議通過公布。

